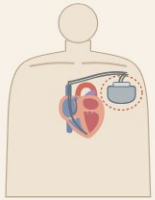


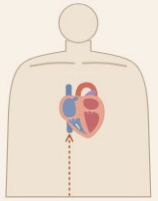
胸前那一塊，可以不要嗎？

兩種節律器，都能在心跳太慢時幫心臟**補上一拍**。差別在**主機放哪裡、有沒有那條線**。



有導線

主機放胸前口袋，
導線沿血管進心臟



無導線

小裝置從鼠蹊部血管
直接送進心臟

	有導線	無導線
01 **看得到的**	胸前開一個口袋放主機，看得到一塊鼓起。	胸前沒有口袋和鼓包；鼠蹊部留一個穿刺小傷口。
02 **那條線**	心臟跳一下，導線就跟著彎一下，一天約 10 萬次（以每分鐘 70 下估算）；用久了，在慣用的凹折處容易破損。	身上沒有這條線，就沒有導線磨損、斷裂的問題。
03 **每天的生活**	初期導線還沒長牢，舉手、揮桿、游泳容易讓它移位，要依醫師指示；長牢之後，手臂常用的角度天天反覆彎折，導線仍會隨時間磨損。	沒有導線被拉扯、彎折的顧慮；何時恢復運動，同樣依醫師指示。

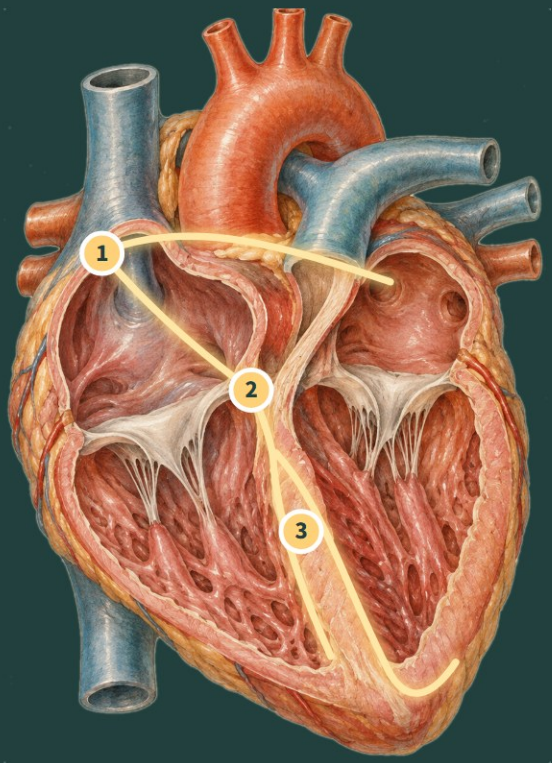
要先知道　無導線少的是「口袋」和「那條線」。植入本身仍有出血、感染、心臟穿孔等風險，也不是每個人都適合。

診間可以這樣問

以我的狀況，有導線和無導線，各有什麼好處、要注意什麼？

示意圖非實際植入位置與比例。本單張為衛教說明，不取代醫師判斷；各型號台灣核准、院內有無、費用與給付，以院方說明為準。

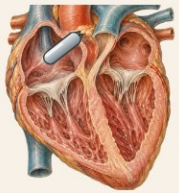
心臟的電路



1. **發電機（竇房結）** 在樓上的心房，負責起頭。
2. **中繼站（房室結）** 停一下，再把訊號往樓下傳。
3. **傳導束（含左束支）** 心臟自己的高速公路，一口氣把訊號送遍心室，左右同時收縮。

我的心，是哪裡慢了？

先找出電路是哪一段慢了、心室要靠機器帶多少，**才知道哪一種節律器適合您。**

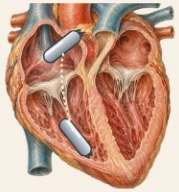


發電機慢了，訊號還傳得下去

例如有症狀的病竇症候群（需醫師確認）

→ **心房型** 一顆放在心房

直接幫心房起跳，下面照常自己往下傳。

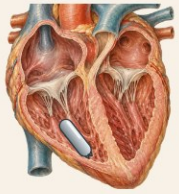


發電機和中繼站都需要幫忙

上下兩層都要有人照顧

→ **雙腔型** 心房、心室各一顆

兩顆互相通訊，協助上下照順序跳。

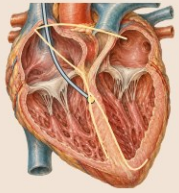


長期心房顫動，只需偶爾補拍

心房已無法規律收縮，要補的拍數不多

→ **心室型** 一顆放在心室

心跳太慢時，幫心室補一拍。



心室大部分時間要靠機器帶

由醫師從心電圖與檢查預估

→ **先談傳導系統節律** CSP・有導線

從心室底部起跳，訊號不走高速公路；長期大量這樣跳，心臟可能慢慢變大、變無力。所以不建議只單裝一顆；比例高時，接在高速公路入口的有導線 CSP 可能更適合。

節律器不是挑功能最多的，是挑和您的心對得上的。

實際適合哪一種，由醫師依心電圖與檢查評估。圖中點狀虛線代表兩顆裝置之間的通訊，不是導線。上下照順序跳，不等於保證不會心臟衰竭，仍需定期回診。



電池用完那天，要怎麼換？

越年輕裝，這輩子越可能遇到換機。**選的時候，就把「以後怎麼換」一起想進去。**

有導線

電池在胸前主機

電池用完時，換胸前的主機，原本的導線多半繼續使用。

導線若老化或損壞，拔除有一定風險，有時只能留在原處、再放一條新的；血管裡的線可能越來越多。

無導線

電池在裝置本體

有些設計附專用回收構造，醫師可評估從血管把舊的取出、再放新的；也可以停用留在原處，另放一顆。

能不能取出，和放了多久、被組織包覆的程度、位置有關，事前無法保證；心臟裡能放的顆數也有限。電池能用多久，依型號與設定而不同。

需求改變時

可以往上加

有些無導線心房型，若日後心室也需要支持，經醫師評估，相容型號可以再加一顆，變成雙腔。

平常怎麼顧

兩種都一樣

定期回診，讓醫師檢查電池還剩多少、設定合不合適。頭暈、喘請提早回診；若昏倒，請盡快就醫。

無導線・留給以後

把血管留得通暢

無導線省下的，是胸前的口袋，和留在血管裡的導線。雙腔本來就是兩條；導線放進去幾乎拿不出來，壞了多半是再加一條。

把血管留得通暢，日後其他疾病要檢查、治療，**才有路可走**。

✂ 沿虛線剪下，帶去診間

看診時，請問醫師這三題

醫師的回答，可以直接寫在線上。

1. **我慢的是哪一段？心室預估要靠機器帶多少？**
2. **有沒有能直接幫心房的無導線？適合我嗎？**
3. **電池用完或需求改變時，取出、留著、升級怎麼安排？**

我的心跳狀況：_____ 回診日：____月____日

示意圖非實際植入位置與比例。本單張為衛教說明，不取代醫師判斷；各型號台灣核准、院內有無、費用與給付，以院方說明為準。